

PDF ANONIMIZADO

ID publico: case_0260

Paginas del documento: 10

Copia anonimizada para verificacion metodologica.

Se removieron portada editorial, titulo, autores, afiliaciones, correos, DOI, URLs y metadatos del PDF original.

Las paginas restantes conservan el contenido util para revisar metodos, resultados, tablas y conclusiones.

Nota: la anonimización automatica prioriza reducir la identificacion directa del articulo. Los casos de una sola pagina o diseno no convencional deben revisarse manualmente antes de una publicacion abierta.

ia were observed. All variables were
nd according to gender and age. To
that influence the presence of uri-
ogistic Regression was performed.

Results: most people were between 60 and 69 years old, had incomplete primary education and had a good perception of their own health, being independent in basic activities. Forty-one people had incontinence, which was often associated with the presence of diabetes, polypharmacy and, in women, the absence of estrogen replacement.

Conclusion: the study shows the importance of investigating the syndrome in the geriatric population, since it's still linked to taboos and underdiagnosed, despite its verifiable impact on the quality of life of the elderly.

Keywords: elderly people, urinary incontinence, health care for the elderly.

Resumen

Objetivo: identificar la prevalencia de incontinencia urinaria y factores asociados en una población de adultos mayores atendidos en un consultorio escolar.

Método: estudio observacional transversal, realizado mediante búsqueda en las historias clínicas de 108 ancianos atendidos en un ambulatorio interdisciplinario de una clínica escolar ubicada en la ciudad de São Paulo. Se incluyeron personas mayores de 60 años, con atención brindada desde el segundo semestre de 2015 hasta junio de 2019. Se recogieron las siguientes variables: sexo, edad, escolaridad, estado civil, enfermedades en tratamiento, existencia de polifarmacia, autopercepción de salud, desempeño en actividades de la vida diaria y referencia a caídas. En las mujeres se verificó la presencia o ausencia de reposición de estrógenos y en los hombres la presencia de hiperplasia prostática. Respecto a la incontinencia urinaria se observó su prevalencia, tipo, limitante o no, y existencia de nicturia. Todas las variables se analizaron de forma conjunta y según sexo y edad. Para identificar los factores que influyen en la presencia de incontinencia urinaria se realizó Regresión Logística.

Resultados: la mayoría de las personas tenían entre 60 y 69 años, tenían educación primaria incompleta y tenían buena percepción de salud, siendo independientes en las actividades básicas. Cuarenta y una personas padecían incontinencia, que se asoció con la presencia de diabetes, polifarmacia y, en las mujeres, ausencia de reposición de estrógenos.

Conclusión: el estudio muestra la importancia de investigar el síndrome en la población geriátrica, que aún está vinculado a tabúes y subdiagnosticado, a pesar de su impacto en la calidad de vida de los ancianos.

Palabras clave: anciano, incontinencia urinaria, atención de salud al anciano.

Introdução

Síndromes geriátricas são condições de saúde complexas que podem acometer, principalmente, as pessoas idosas mais frágeis e que não se enquadram em categorias de doenças definidas. Frequentemente são consequências de múltiplos

interdisciplinar para que não ocorra significativa perda de qualidade de vida. Têm importante papel no envelhecimento, pois caracterizam-se por evoluírem de modo crônico, comprometerem a independência funcional e se relacionarem com a mortalidade da pessoa idosa.¹

Dentre as síndromes geriátricas, a incontinência urinária/esfincteriana (IU) ocupa um relevante espaço por se constituir em um dos problemas mais comuns na idade avançada, sendo mais frequente em mulheres.¹⁻⁴

A IU é definida pela queixa de qualquer perda involuntária de urina pelo indivíduo e pode ser classificada em três grupos: incontinência urinária de estresse (IUE), incontinência urinária de urgência (IUU) e incontinência urinária mista (IUM).

A IUE caracteriza-se pelo escape de urina que ocorre de forma síncrona ao esforço, tosse ou espirro. Já na IUU, a perda se associa ou é imediatamente sucedida de urgência miccional, sendo constante a vontade de urinar em pequenas quantidades (polaciúria) e reiteradamente durante a noite (noctúria) interrompendo o sono do indivíduo. Quanto à IUM, engloba as duas anteriores.¹⁻⁵

Sobre a incontinência urinária por transbordamento, ela se diferencia pelo gotejamento e/ou perda constante de urina associados ao esvaziamento vesical incompleto, devido à deficiência do músculo detrusor e/ou obstrução na via de saída vesical. Sobre a incontinência urinária funcional, a pessoa idosa acometida apresenta outras condições que dificultam ou impedem, tais como locomoção dificultada, alteração de memória e uso de medicamentos, que culminam na perda de urina.¹⁻⁵

O estudo da incontinência urinária e seus sintomas se torna de extrema relevância para os profissionais da saúde, haja vista não só o número expressivo de pessoas idosas dentre a população mundial, mas a sua relação com o isolamento social dos portadores da síndrome e as repercussões psíquicas relacionadas tanto ao

interpretada como um processo de envelhecimento e os sintomas são, muitas vezes, subvalorizados e não tratados de forma adequada, o que piora gradativamente o quadro.^{6, 7}

No estudo de Virtuoso e colaboradores⁸ se observou que mulheres idosas não consultaram um médico a respeito dos sintomas de incontinência por acreditarem que eram resultantes do próprio envelhecer. Além disso, algumas relataram não se sentirem confortáveis em abordar o tema e contar os sintomas aos profissionais da saúde, evidenciando o quanto a IU ainda é tema tabu.

Pesquisa realizada pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS)⁹, detectou que, dentre os brasileiros com idades entre 60 e 74 anos, 22% das mulheres e 9% dos homens apresentavam IU. Nas pessoas acima de 75 anos, os valores foram ainda mais significativos, com 36% das mulheres e 23% dos homens acometidos. Entretanto, mesmo sendo uma síndrome que afeta grande número de pessoas idosas, 78% destas ainda desconhece que qualquer perda involuntária de urina é considerada incontinência urinária, restando clara a importância da conscientização a respeito desse tema, tanto para a população quanto para os profissionais de saúde.

A IU já é considerada um problema de saúde pública mundial, sendo uma preocupação entre os profissionais da saúde, pois afeta diversas esferas na vida do indivíduo acometido, levando, além do distanciamento social, a sintomas depressivos e ansiedade em decorrência da vergonha frente aos episódios de perda de urina.⁷ Os impactos negativos na participação social dos idosos afetados são uma grande barreira para a promoção de um envelhecimento saudável e se relacionam a multimorbidades diversas devido ao isolamento das pessoas afetadas.¹⁰

Os fatores associados à perda involuntária de urina são diversos, dentre eles: a idade avançada, o sexo feminino, o número de multimorbidades, o

A incapacidade de andar, a demência e o sexo feminino são considerados riscos importantes para o desencadeamento de IU, assim como o estilo de vida sedentário e a prática de atividade física em menos de 150 minutos semanais.^{11, 12}

A literatura aponta que a IU é uma condição de saúde que preestabelece o advento de outras multimorbidades e síndromes geriátricas, tais como quedas e depressão. Constatou-se, em um estudo desenvolvido na Coreia, que dentre 6.134 mulheres idosas com IU, cerca de 18,78% apresentaram pelo menos uma queda no último ano, eventos estatisticamente associados.¹³ Quanto à manifestação de sintomas depressivos, sabe-se que a perda de urina gera vergonha e constrangimento à pessoa idosa, que acaba se isolando de suas redes, importante gatilho para quadros de ansiedade e depressão.⁷

Tendo este contexto como norte, este estudo buscou identificar a prevalência de IU e os fatores associados a esta síndrome em uma população idosa atendida em um ambulatório interprofissional de uma clínica-escola localizada em São Paulo, SP, Brasil.

Método

Trata-se de um estudo observacional transversal realizado mediante a busca ativa em prontuários de pessoas idosas atendidas em um ambulatório interdisciplinar de uma clínica-escola, vinculado a um centro universitário, localizado no município de São Paulo.

Este ambulatório foi fundado no segundo semestre de 2015, período no qual os atendimentos foram iniciados, sendo realizados uma vez por semana, contando como treinamento prático para estudantes dos cursos de medicina, nutrição e fisioterapia da instituição de ensino superior. É um serviço filantrópico, gratuito, não vinculado ao sistema público de saúde, que atende pessoas que o procuram espontaneamente ou são encaminhadas por instituições do terceiro setor. O acesso é vinculado à insuficiência de renda e

pesquisa, analisaram-se os dados das pessoas idosas atendidas pelo ambulatório desde o seu início até junho de 2019. Como critérios de inclusão, bastava ser pessoa acima de 60 anos, moradora no município de São Paulo, com atendimento realizado a partir do segundo semestre de 2015 até junho de 2019.

A coleta de dados foi realizada em julho de 2019. Os dados dos 108 prontuários analisados foram armazenados em planilha de Excel® e submetidos a tratamento estatístico pelo Stata® versão 15.0 (StataCorp LLC, College Station, TX, USA).

As variáveis demográficas coletadas foram: sexo, idade, escolaridade e estado civil. Levantou-se, ainda, as doenças em tratamento, existência de polifarmácia, autopercepção de saúde, o desempenho nas atividades básicas de vida diária (ABVD) e instrumentais de vida (AIVD) e a referência a quedas. Para as mulheres, verificou-se a presença ou não de terapia hormonal estrogênica e, para os homens, a presença de hiperplasia prostática. Quanto à IU, observou-se sua presença, o tipo de incontinência, se a IU era limitante ou não, além da existência de noctúria. Todas essas variáveis foram analisadas em conjunto e separadamente conforme o sexo e a idade.

Para a estatística descritiva, as variáveis qualitativas foram analisadas em suas frequências absolutas (n) e frequências relativas (%). Já para as variáveis quantitativas, utilizou-se média e a mediana e, a fim de apontar a variabilidade, desvio-padrão, valor mínimo e máximo.

A seguir, após análise da normalidade pelo teste de Shapiro-Wilk ($p < 0,05$), foram utilizados teste Qui-Quadrado ou teste exato de Fisher, quando necessário, para as variáveis qualitativas, e teste t-Student, para as quantitativas. A fim de identificar os fatores que influenciam a presença de incontinência urinária, os dados

sexo e a idade. Também foi realizada a análise de Regressão Logística, método *stepwise forward* que não inclui no modelo final as variáveis que, analisadas conjuntamente, apresentavam-se sem significância estatística. Desta forma, das variáveis inicialmente inseridas no modelo, apenas entraram no modelo final aquelas que apresentaram significância estatística ($p < 0,05$). Para todos os testes foi considerado um nível de significância de 5%.

A pesquisa recebeu aprovação ética conforme parecer de número 3.272.027, abril de 2019.

Resultados

Foram analisados 108 prontuários de pessoas idosas, sendo que 78 (72,22%) eram do sexo feminino e 30 (27,78%) do masculino. A faixa etária média foi de 72 anos ($s = 7,40$), com idade mínima de 60 anos e idade máxima de 92 anos. A maioria tinha entre 60 e 69 anos (47 pessoas, 43,52%), com ensino fundamental incompleto e boa percepção de saúde, sendo independentes para as ABVD e AIVD (Tabela 1).

Na análise das doenças crônicas, 81 (75,00%) tinham diagnóstico de hipertensão arterial, 45 (41,67%) possuíam diabetes mellitus e 45 (41,67%) tinham depressão. Dentre os homens, 20 (66,67%) apresentavam doença prostática benigna e dentre as mulheres, 13 (16,67%) referiram fazer terapia hormonal estrogênica.

Sobre a IU, 41 (37,96%) pessoas idosas apresentaram este diagnóstico, sendo que três (2,78%) possuíam incontinência limitante (Tabela 2). Em relação ao tipo de incontinência, obteve-se dez (9,26%) casos de IU de Esforço, 12 (11,11%) casos de IU de Urgência, dez (9,26%) de IU Mista e quatro (3,70%) com esvaziamento vesical inadequado. Cinco (4,70%) prontuários não especificaram o tipo de IU. Referiram noctúria 46 (42,59%) pessoas.

Variáveis	n	%
<i>Estado civil</i>		
Relação estável	45	41,60
Viúvos	34	31,50
Solteiros	15	13,90
Separados	14	13,00
<i>Escolaridade</i>		
Ensino fundamental completo	21	19,40
Ensino fundamental incompleto	44	40,70
Ensino médio completo	33	30,60
Analfabetos	10	9,30
<i>Autopercepção de saúde</i>		
Boa/ ótima autopercepção	85	78,70
Ruim/péssima autopercepção	23	21,30
<i>ABVD</i>		
Independentes	74	68,52
Dependentes	34	31,48
<i>AIVD</i>		
Independentes	67	62,04
Dependentes	41	37,96

Tabela 2 – Valor de p, regressão *stepwise forward*, presença de incontinência urinária e variáveis significativas, grupo de pessoas idosas, 2019.

Incontinência urinária	n (%)	valor p
Total	41 (38,0)	-
<i>Sexo</i>		0,477
Masculino	12 (40,0)	
Feminino	29 (37,2)	
<i>Idade</i>		0,172
60-69 anos	19 (40,4)	
70-79 anos	11 (27,5)	
80 anos ou mais	11 (52,4)	
<i>Noctúria</i>		0,146
Não	15 (30,6)	

Não	8 (22,9)	
Sim	33 (45,2)	
<i>Diabetes</i>		0,047
Não	18 (29,5)	
Sim	23 (48,9)	

Dentre as variáveis com significância estatística para a realização da regressão: sexo, idade, noctúria, polifarmácia e *diabetes mellitus*, apenas as duas últimas foram associadas à IU ($p < 0,05$) (Tabela 2). Na análise multivariada, a presença de polifarmácia aumentou em 11,37 vezes (OR=11,37, IC=95%, $p=0,014$) e de diabetes 4,79 vezes a chance (OR = 4,79, IC = 95%, $p=0,006$) de desenvolvimento de IU.

Notou-se, ainda, que as mulheres idosas que não realizavam terapia hormonal estrogênica apresentaram 8,37 vezes mais chances (OR = 8,37, IC = 95%, $p=0,060$) de apresentar IU.

Discussão

O perfil demográfico do grupo estudado não difere do encontrado para o estado e cidade de São Paulo. O estado apresenta um processo de envelhecimento progressivo e constante. Já o município, tem distribuição etária diferenciada entre seus distritos. Enquanto os mais centrais e com maior renda apresentam envelhecimento acentuado, com média de idade de 78-80 anos, os mais periféricos, devido às desigualdades, mostram locais onde a expectativa de vida não ultrapassa 59 anos. Porém, em média, a esperança de vida ao nascer vem tendo incremento na cidade, predominando as faixas etárias entre 60 e 70 anos de idade, sempre com maioria de mulheres.^{14, 15}

Quanto à escolaridade das pessoas idosas na cidade, evidencia-se que a população de mais baixa renda, como a aqui estudada, possui elevado índice de analfabetismo e ensino fundamental incompleto, corroborando o achado neste estudo.¹⁵

saudável é a autopercepção de saúde, sendo que piores avaliações representam mais risco para eventos adversos, como doenças. Estudos demonstram que autonomia e preservação da capacidade funcional têm sido relacionadas à autopercepção de saúde positiva,^{19, 20} corroborando com os resultados da presente pesquisa, que evidencia autopercepção da saúde boa/ótima predominante em pessoas idosas majoritariamente independentes para as atividades de vida, instrumentais e básicas.

Com relação às doenças crônicas não transmissíveis, evidenciou-se, para o grupo ora descrito, prevalência de hipertensão arterial e *diabetes mellitus*, ratificada por dados obtidos para a população geriátrica brasileira.¹⁸

Destaca-se o quantitativo de diagnósticos de depressão obtido neste estudo, visto que esta condição de saúde mental ainda é negligenciada em pessoas idosas, já que os sintomas costumam ser relacionados às características do próprio envelhecimento.¹⁹ Dentre os fatores de risco para depressão estão o gênero feminino e possuir baixo nível socioeconômico,²⁰ fato correlacionado ao perfil sociodemográfico dos participantes desta pesquisa.

A hiperplasia benigna prostática (HPB) é resultante de multiplicação celular não neoplásica relacionada ao processo de envelhecimento masculino, com elevada prevalência nas idades entre 50 e 70 anos. Caracterizada por hiperplasia do estroma e das glândulas prostáticas, sobretudo na zona de transição, acompanhada de hipertrofia do músculo liso, causa aumento do volume da próstata e consequente compressão da luz uretral (fator mecânico) com maior contração da

e vesical causando sintomas de
mo sensação de esvaziamento
eto, incontinência paradoxal,
noctúria, polaciúria, urgência miccional, entre
outros.^{21, 22}

Estudos mostram prevalências de HPB
semelhantes às encontradas no grupo
pesquisado, variando de 50% entre homens com
50 anos e chegando a 90% entre os idosos com
90 anos.^{23, 24}

A proporção de IU encontrada nesta pesquisa
é semelhante à vista em outros estudos.^{10-12, 28}
Notou-se diferenças poucas significativas na
prevalência de IUE, IUU e IU mista. A IUE costuma
ser normalizada pela população idosa e menos
relatada como queixa em consultas médicas.
Porém, quando os indivíduos são questionados,
identifica-se o sintoma.²⁶

Já a noctúria, caracterizada pela necessidade
de esvaziamento da bexiga durante a noite, se
mostrou bastante presente dentre as pessoas
idasas participantes desta pesquisa. Esse sintoma
obriga o indivíduo a se levantar para urinar de uma
a mais vezes durante a noite, o que prejudica a
qualidade do sono da pessoa idosa e é associado
ao maior número de quedas, apresentando,
portanto, grande importância para a saúde dessa
população.²⁷

Estudo realizado com a população brasileira²⁸
demonstrou que, conforme aumenta a idade,
maior a prevalência de sintomas do trato urinário
inferior. Assim, estima-se que 60% dos homens e
73,5% das mulheres com 60-69 anos, apresentam
algum sintoma miccional. Destes sintomas,
urgência miccional e IU de urgência foram os que
mais incomodam os homens e perdas urinárias
involuntárias, enurese noturna e gotejamento
pós-miccional os que mais incomodam as
mulheres.

No estudo ora apresentado, não foi evidenciada
associação estatisticamente significativa
entre idade, sexo e IU, contrariando estudos
que relatam estes fatores como preditores de
IU.^{6, 12, 29} Evidenciou-se, entretanto, associação

incontinência.

Vários estudos demonstram a associação
entre IU e diabetes,^{6, 12, 30} fato que pode ser
explicado pelo distúrbio metabólico gerado pela
enfermidade, acarretando alteração na fisiologia
do músculo detrusor, disfunção neuronal vesical
e inflamação microvascular. Acredita-se que
a elevada glicemia lese os nervos autônomos
da bexiga, prejudicando o mecanismo de
enchimento e esvaziamento vesical. A glicosúria
poderia agravar ainda mais a IU por aumentar a
frequência urinária.

Outra associação encontrada para IU, neste
grupo de pessoas pesquisadas, foi a presença
de polifarmácia, a qual eleva em 11,37 vezes a
ocorrência de IU. Diante da presença de doenças
crônicas e comorbidades, as pessoas idosas
podem fazer uso de cinco ou mais medicamentos
e a literatura já aponta a polifarmácia como um
dos fatores de risco para a IU.^{31, 32}

Dentre os medicamentos que se mostraram
como principais desencadeantes da síndrome
estão os diuréticos, principalmente os de alça,
pois geram aumento do volume urinário. Além
destes, antidepressivos inibidores da recaptção
de serotonina e noradrenalina, devido à elevação
da concentração desses neurotransmissores
nas fendas sinápticas, ocasionam estímulo à
contração do músculo detrusor, elevando os
episódios de perda de urina.³¹

Estão também conectados à IU os
sedativos e hipnóticos de longa duração;
opiáceos; anestésicos; simpaticomiméticos e
parassimpaticolíticos; drogas bloqueadoras dos
receptores alfa-adrenérgicos; bloqueadores do
canal de cálcio; inibidores da enzima conversora
da angiotensina, dentre outros.^{12, 32}

Foi evidenciada associação, nas mulheres
que compuseram o grupo pesquisado, entre a
não realização de terapia hormonal e a presença
de IU. A terapia hormonal vem sendo descrita
como eficaz no controle da IU em mulheres
pós-menopausa, pois esse hormônio age
diretamente sobre a uretra. Porém, pode ser

há riscos nessa terapia, pelos riscos de neoplasias mamárias e, o uso da terapia hormonal é controverso.^{33, 34}

Conclusão

Esta pesquisa buscou gerar dados que auxiliem os profissionais de saúde a ficarem mais atentos aos sintomas de perda urinária relatados pela pessoa idosa, bem como aos seus fatores de risco. Além disso, visa incentivar a busca ativa por IU na população geriátrica, tanto feminina quanto masculina.

Foi evidenciada a prevalência de IU e de fatores associados a esta síndrome, tais como diabetes, polifarmácia e terapia hormonal em mulheres. Como limitações, a pesquisa baseou-se em dados de prontuário, portanto em IU autorreferida. Como contribuições, o estudo mostra a importância de averiguar a síndrome na população geriátrica, a qual ainda é ligada a tabus e subdiagnosticada, apesar de seu impacto na qualidade de vida da pessoa idosa. Com o envelhecimento populacional, é crucial que tenhamos um olhar ampliado para as necessidades em saúde deste segmento etário.

Contribuições individuais dos autores

Maria Elisa Gonzalez Manso realizou concepção e desenho do estudo, análise e interpretação dos dados, revisão crítica das versões preliminares, elaboração e aprovação da versão final, responsável por todos os aspectos do trabalho.

Renata Laszlo Torres realizou análise e interpretação dos dados, elaboração das versões preliminares, elaboração e aprovação da versão final, responsável por todos os aspectos do trabalho.

Maria Clara Conti Martins realizou análise e interpretação dos dados, elaboração das versões preliminares, elaboração e aprovação da versão final, responsável por todos os aspectos do trabalho.

versão final, responsável por todos os aspectos do trabalho.

Monique Teixeira Costa realizou análise e interpretação dos dados, elaboração das versões preliminares, elaboração e aprovação da versão final, responsável por todos os aspectos do trabalho.

Declaração de conflitos de interesse e suporte financeiro

As autoras declaram não haver conflito de interesse. A pesquisa foi suportada pelas autoras.

Referências

Maria Elisa Gonzalez Manso

Doutora em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), em São Paulo, SP, Brasil; com pós-doutorado e mestrado em Gerontologia Social pela mesma instituição. Médica. Professora titular curso de medicina do Centro Universitário São Camilo, em São Paulo, SP, Brasil.

Renata Laszlo Torres

Mestrado em Enfermagem pela Universidade de São Paulo (USP), em São Paulo, SP, Brasil. Enfermeira. Professora do curso de medicina do Centro Universitário São Camilo (CUSC), em São Paulo, SP, Brasil.

Maria Clara Conti Martins

Graduanda de medicina no Centro Universitário São Camilo (CUSC), em São Paulo, SP, Brasil.

Rafaella Camargo Simoes Zaninotto

Graduanda de medicina no Centro Universitário São Camilo (CUSC), em São Paulo, SP, Brasil.

Monique Teixeira Costa

Graduanda de medicina no Centro Universitário São Camilo (CUSC), em São Paulo, SP, Brasil.

Maria Elisa Gonzalez Manso

Av. Nazaré, 1501

Ipiranga, 04263-200

São Paulo, SP, Brasil

Os textos deste artigo foram revisados pela SK Revisões Acadêmicas e submetidos para validação do(s) autor(es) antes da publicação.